中醫-拔罐治療注意事項

一、何謂拔罐治療法

拔罐治療又稱吸杯法、吸筒療法，即排除罐中空氣，造成負壓，吸著於皮膚，形成局部充血或瘀血現象後，具有行氣、消腫、祛寒等作用。使罐吸拔並留置於施術部位 10-15 分鐘，然後將罐起下。

二、拔罐治療原理介紹

主要作用是刺激舊病灶，啟動身體自我療癒的效果。

(一) 負壓效應作用：拔罐的負壓真空作用使局部迅速充血，造成輕微的小毛細血管破裂形成瘀血，引起局部輕微的發炎反應。造成皮膚的慢性刺激，可提高人體對外界變化的敏感性及耐受力，增強身體的免疫力。

(二) 機械刺激作用：拔罐療法通過排氣造成罐內負壓，牽拉了神經、肌肉、血管以及皮下的腺體，調節血管收縮功能和血管的通透性從而改善局部血液循環。

(三) 溫熱作用：拔罐局部血管擴張、血流量增加，血管壁的通透性和細胞的吞噬能力增強，引起淋巴循環加速故整體血液循環改善而產生溫熱作用。

三、拔罐適應症

拔罐療法極為廣泛，主要用於風濕麻痛的症狀，如慢性肌肉疲勞的耗損，引起頸肩背腰痠痛、肌腱炎、五十肩。拔罐部位應選擇在肌肉豐盈平整而具有彈力，無毛髮的部位，如肩胛、背部、腰部等。需避開生殖器，五官黏膜處，肌肉削瘦或骨凸關節、毛髮多及大血管處。

(一) 拔罐禁忌症：把握「急性期、過敏期、行經妊娠期」三不原則。

1. 急性期：高熱痙攣如熱症而引發之頭痛、目眩、抽搐、關節痛，癲狂躁動病人，不適用拔罐。心血管病史，特別有左後背疼痛（疑似心絞痛病兆），極度衰弱，凝血及出血等疾病者不適用拔罐。

三軍總醫院 護理部 中醫部 編印
諮詢電話：(02)87927056
46-CMC-13（2018.04 醫療紀錄管理審議會審核通過）-1-

2. 過敏期：皮膚呈現嚴重過敏或極度水腫部位，皮膚病變、皮膚潰瘍、傷口不易癒合，或皮膚表面脆弱且失去彈性處，皆不適用。
3. 行經妊娠期：生理期、妊娠期或懷疑妊娠時。
4. 70 歲以上老人、或 6 歲以下兒童，應避免自行拔罐治療。

(二) 拔罐注意事項：仰躺、俯臥在床上或採坐姿選有靠背及扶手的椅子以舒服為原則，若有任何不適，則立刻停止。

1. 消毒：施術者手部及預拔罐之部位、拔罐器具等需適當消毒後使用。
2. 塗油：尤其是走罐時，一定要塗潤滑油，如凡士林、推拿油膏。
3. 起罐：按壓罐口的一側皮膚，造成漏氣，罐子則自動脫落，切忌硬拉硬扭，造成皮膚傷害。
4. 皮膚狀態：拔罐後皮膚正常會出現圓形瘀血等現象，若無出現水泡則過幾天會自行消退，若出現水泡可塗抗生素藥膏，並以消毒紗布覆蓋，如出現感染請盡速就醫。

四、意外之預防與處理

(一) 過度疼痛及皮膚造成損壞

1. 原因：起罐手法太猛、皮膚受到牽引造成皮膚較細之部位疼痛，紅腫破皮。
2. 處理：過度瘀血之處，短期內不可再拔罐。

(二) 休克

1. 原因：體質虛弱、大飢大渴、過飽過勞、心血管疾病、刺激部位太多，病人無法承受等。
2. 處理：看見病人臉色蒼白、呼吸急促、四肢厥冷、冒汗等暈罐情形，則應立即起罐，使病人平臥，下肢墊高，頭部放低，休息片刻，清醒時可給一杯溫水，亦可用百會、合谷、少商、人中、湧泉等暈針急救穴。

六、參考資料

杜鳳棋、余哲仰、陳俊勳（2015）. 利用數值分析探討拔罐對皮膚可能造成的熱傷害. *機械技師學刊*，*8*（1），22-26。

林恭儀、戴承杰、林展弘（2017）. 古老的醫療技能－細說拔罐. *台北市中醫醫學雜誌*，*23*（1），9-13。

護理指導評值

1. （ ） 拔罐一次留置於部位的時間為 10-15 分鐘。
2. （ ） 若病人今天沒有吃任何東西也是可以拔罐的。
3. （ ） 拔罐的姿勢，仰躺、俯臥在床上或採坐姿，並選有靠背及扶手的椅子，以舒服為原則。
4. （ ） 拔罐過程中出現何種情形需要立即起罐? (1)臉色蒼白 (2)四肢厥冷 (3)呼吸急促 (4)冒汗 (5)以上皆是。
5. （ ） 拔罐須避開的部位是? (1)骨凸關節 (2)肌肉豐盈平整的部位 (3)背部 (4)腰部。
6. （ ） 拔罐的禁忌症有? (1)行經妊娠期 (2)心血管病史 (3)凝血及出血等疾病者 (4)70 歲以上老人、或 6 歲以下兒童自行拔罐 (5)以上皆是。

(答對 5-6 題：完全了解；答對 3-4 題：部分了解；答對 1-2 題：完全不了解)

1.（O） **2.**（X） **3.**（O） **4.**（5） **5.**（1） **6.**（5）